

Evaluation

Cours De Résidanat Sujet:57

Péritonites aiguës

TCEM

Pr Ag Nizar Kardoun

Service de Chirurgie Générale

2/07/2025

Objectifs éducationnels



1- Définir les péritonites aiguës (PA)

- 2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA
- 3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA
- 4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA
- 5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA
- 6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA
- 7- Etablir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques
- 8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 1



La péritonite aigue :

A- Est l'inflammation aigue d'une partie de la séreuse péritonéale

B- Est le plus souvent d'origine infectieuse

C- Est une urgence médicale

D- Peut se voir à tout âge

E- Est de diagnostic clinique

Objectifs éducationnels



1- Définir les péritonites aiguës (PA)

2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA

3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA

4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA

5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA

6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA

7- Établir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques

8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 2



Les péritonites aiguës :

A- Surviennent souvent sur un terrain fragile

B- Tertiaires sont les plus fréquentes

C- Peuvent être secondaires à l'infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique

D- Représentent environ 30% des syndromes douloureux aigus de l'abdomen

E- peuvent être post-opératoire

Objectif 2



Le mode contamination d'une péritonite aigue peut être :

A- Par voie hématogène

B- Par inoculation de germes

C- Secondaire à une pancréatite aigue sans perforation d'un organe creux

D- Par translocation bactérienne

E- Par voie lymphatique

Objectif 2



Les péritonites aiguës primitives :

A- Sont fréquentes

B- Sont souvent poly-bactériennes

C- Sont des urgences essentiellement chirurgicales

D- Par infection du liquide d'ascite représentent l'étiologie la plus fréquente chez l'adulte

E- Sont essentiellement secondaires à une contamination par voie hématogène

Objectif 2



Une péritonite aiguë secondaire peut être suite à une contamination par:

A- Une effraction traumatique d'un viscère creux

B- Un foyer septique intra abdominal

C- Une Rupture intra abdominale d'une suppuration

D- La voie sanguine

E- La voie lymphatique

Objectif 2



Les péritonites bactériennes secondaires :

- A. sont rares
- B. Peuvent être post traumatiques
- C. D'origine gynécologique sont les plus fréquentes
- D. Sont mono bactérienne
- E. Peuvent être post opératoire

Objectif 2



Les péritonites bactériennes secondaires :

- A. Peuvent être chimique au début
- B. Peuvent être par diffusion des germes
- C. Sont dues à des Cocci Gram +
- D. Sont dues au BK
- E. D'origine appendiculaire sont les plus fréquentes

Objectif 2



A propos des péritonites bactériennes primitives :

- A. Elles surviennent en présence d'un foyer infectieux primitive intra abdominal
- B. La contamination peut être suite à une translocation bactérienne
- C. Le pneumocoque est le germe le plus fréquent chez l'enfant
- D. Peuvent être poly microbienne
- E. Le syndrome néphrotique constitue un facteur de risque

Objectif 2



Les péritonites tertiaires:

- A. Sont fréquentes
- B. Sont de diagnostic facile
- C. Sont dues à des germes virulents
- D. Peuvent être dues à des levures
- E. Sont associées dans la plus part des cas à une défaillance multiviscérale

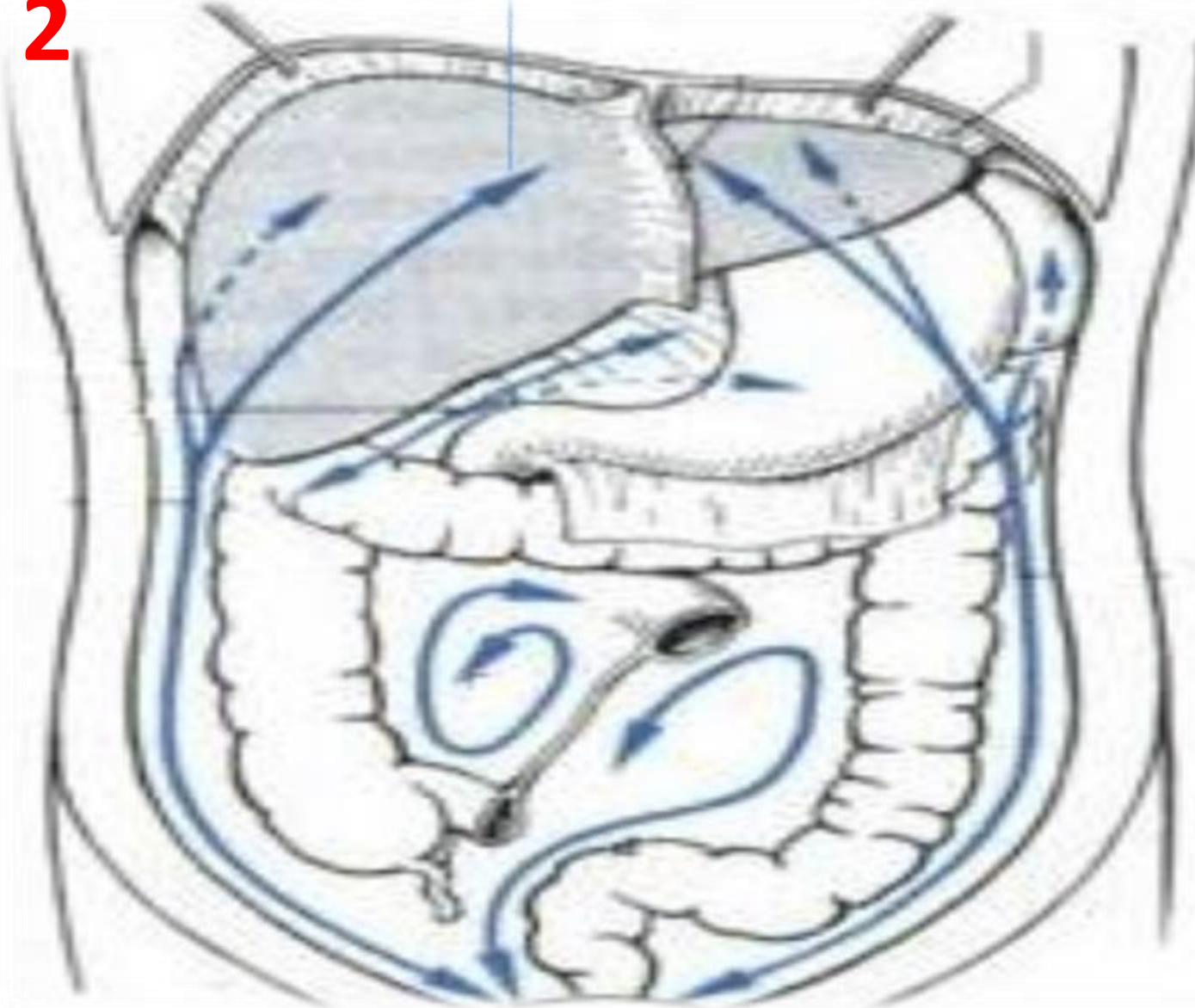
Objectif 2



Une péritonite localisée peut être expliquée par :

- A. La présence de zone déclive
- B. Les courants préférentiels intra-péritonéaux
- C. La pression positive sous phrénique
- D. Les moyens de défense du péritoine
- E. Des adhérences post opératoire

Objectif 2



Objectifs éducationnels



1- Définir les péritonites aiguës (PA)

2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA

3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA

4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA

5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA

6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA

7- Établir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques

8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 3



Les moyens de défense du péritoine sont:

- A. Le pouvoir phagocytaire des cellules péritonéales
- B. Le transsudat diluant des germes
- C. La Réaction fibrinaire
- D. Le passage de germes dans la circulation générale
- E. La capacité adhérentielle

Objectif 3



Les péritonites chimiques:

- A. Sont secondaire à une perforation sous mésocolique
- B. Sont équivalents à une brûlure interne
- C. Deviennent bactérienne au bout de 24h
- D. Sont à l'origine du 3ème secteur
- E. Entraînent une hyponatrémie

Objectif 3



Les péritonites bactériennes:

- A. Peuvent être secondaires à une péritonite chimique
- B. Peuvent être secondaires à une perforation rectale
- C. Sont secondaires à des germes nosocomiaux
- D. Peuvent être à l'origine d'un passage d'endotoxine dans la circulation générale
- E. Sont à l'origine d'un état de choc vasoplégique

Objectif 3



Les manifestations secondaires de la péritonite peuvent être :

- A. Une insuffisance rénale organique au début
- B. Une incompétence myocardique
- C. Une hypolactatémie
- D. Un hypercatabolisme
- E. Une baisse du taux de prothrombine

Objectif 3



Les manifestations secondaires à la péritonite sont :

- A. Une hypovolémie
- B. Une augmentation de la résistance vasculaire périphérique
- C. Une augmentation de la ventilation secondaire à la contracture abdominale
- D. Une oligurie à 0,4 mL/kg/h
- E. Une thrombopénie

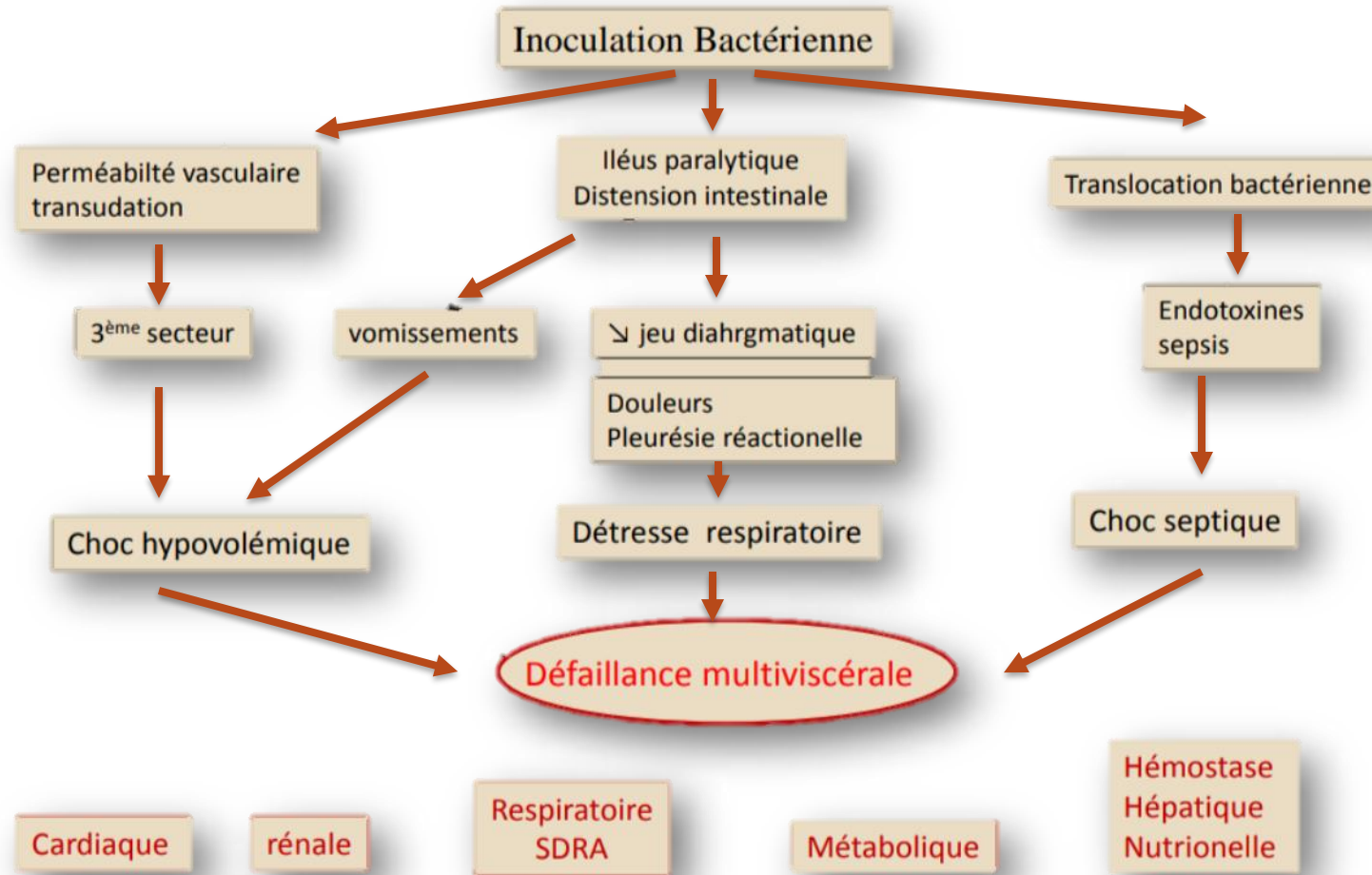
Objectif 3



Parmi les manifestations secondaires à la péritonite on trouve :

- A. Un ictère cholestatique
- B. Une acidose métabolique
- C. Un délire
- D. Une obnubilation
- E. Une coagulation intravasculaire disséminée

Mécanismes physiopathologiques des états septiques



Objectifs éducationnels



1- Définir les péritonites aiguës (PA)

2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA

3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA

4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA

5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA

6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA

7- Etablir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques

8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 4

Parmi les lésions anatomopathologiques des péritonites, on cite:

- A. Une hyperhémie péritonéale
- B. Un épanchement séreux
- C. Une paroi mince des anses intestinales
- D. Un exsudat fibrino-leucocytaire
- E. Une dilatation capillaire



Objectifs éducationnels



- 1- Définir les péritonites aiguës (PA)
- 2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA
- 3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA
- 4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA
- 5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA**
- 6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA
- 7- Établir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques
- 8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 5



Les signes fonctionnels d'une péritonite aigue sont :

A. Une douleur abdominale

B. Une fièvre

C. Une diarrhée

D. Des vomissement

E. Un signe de rovsing

Objectif 5



Concernant le tableau clinique d'une péritonite aigue :

- A. Les vomissements constituent le maitre symptôme
- B. La contracture abdominale est constante
- C. L'arrêt des matières et des gaz est mécanique
- D. La douleur abdominale est permanente**
- E. L'état général est rapidement altéré

Objectif 5



Parmi les signes généraux d'une péritonite aiguë, on peut trouver

- A. Un état général conservé
- B. Un pincement des ailes du nez
- C. Une hypothermie
- D. Une langue sèche
- E. Des vomissements bilieux

Objectif 5



Les signes physiques d'une péritonite aiguë sont :

- A. Un abdomen immobile
- B. Un relâchement des muscles droits de l'abdomen
- C. Une défense généralisée
- D. Un cri du DOUGLAS
- E. Une contracture abdominale

Objectif 5



La défense abdominale est :

- A. Invincible
- B. Permanente
- C. Une contraction reflexe
- D. De même signification que la contracture
- E. Non douloureuse

Contraction des muscles de la paroi de l'abdomen:
Involontaire – douloureuse – vincible à la palpation
profonde – **permanente**

bloquée – **douloureuse**

Objectif 5



la contracture abdominale est :

- A. volontaire
- B. Non douloureuse
- C. Permanente
- D. Invincible
- E. Déclenchée par la palpation

Contraction des muscles de la paroi de l'abdomen:
Involontaire – douloureuse – invincible – permanente et généralisée

« VENTRE DE BOIS »

« AEMKE DE BOIS »

Objectif 5



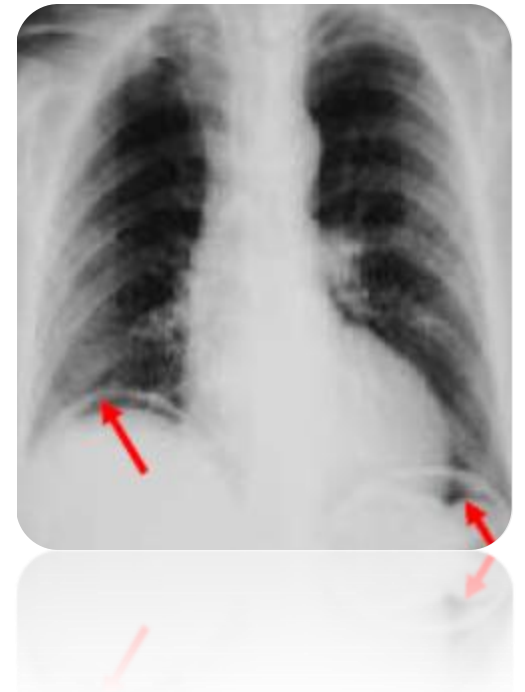
Un syndrome péritonéal typique associe:

- A. Une douleur abdominale diffuse
- B. Une contracture
- C. Un toucher rectal non douloureux
- D. Une hypotension
- E. Une abolition des reflexes cutanés abdominaux

Objectif 5

Le pneumopéritoine:

- A. Est constant en cas de perforation d'un organe creux
- B. Est important en cas de perforation colique
- C. Témoigne de la présence de germes anaérobies
- D. Peut être unilatérale
- E. Peut être remplacé par un NHA sous phrénique



Objectif 5



Le scanner abdominal au cours d'un syndrome péritonéal

- A. Est indispensable au diagnostic positif
- B. Peut mettre en évidence un pneumopéritoine localisé
- C. Permet de rechercher l'étiologie
- D. Est contre indiqué en présence d'une insuffisance rénale
- E. Est utile en cas de péritonite asthénique

Objectif 5



Dans sa forme occlusive la péritonite aiguë est caractérisée par :

- A. Une défense abdominale
- B. Un arrêt des matières et des gaz
- C. Des vomissements bilieux
- D. Un toucher rectal douloureux
- E. La présence des ondulations péristaltiques

Objectif 5



La péritonite aiguë asthénique:

A- Est l'apanage du sujet âgé

B- Est généralement vue tardivement

C- Donne des signes généraux discrets

D- Donne des signes physiques plus marqués

E- Est de diagnostic facile

Objectif 5



Les signes cliniques d'un abcès sous phrénique sont:

- A. Un hoquet
- B. Une toux sèche
- C. Une contracture abdominale
- D. Une douleur spontanée de l'hypochondre
- E. Un toucher rectal douloureux

Objectif 5



A propos des abcès sous phréniques:

- A- Le diagnostic positif repose sur la clinique
- B- Le niveau hydro-aérique à la radiographie ASP est constant
- C- La radiographie du thorax peut montrer une pleurésie
- D- L'échographie abdominale est un examen sensible
- E- Le scanner montre une image hypo dense

Objectif 5



Les abcès sous phréniques peuvent :

- A. Complicuer une pyélonéphrite aiguë
- B. Complicuer l'évolution d'un ulcère perforé bouché
- C. Survenir au décours d'une chirurgie biliaire
- D. Survenir au décours d'une péritonite appendiculaire
- E. Survenir au décours d'une diverticulite non compliquée

Objectif 5



Concernant les abcès du Douglas:

A- la douleur est hypogastrique

B- peut se révéler par une pollakiurie

C- le toucher rectal est normal

D- peut se révéler par un ténesme

E- peut se manifester par une contracture

Objectifs éducationnels



- 1- Définir les péritonites aiguës (PA)
- 2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA
- 3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA
- 4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA
- 5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA
- 6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA**
- 7- Établir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques
- 8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 6



Une péritonite aiguë est grave :

- A. En présence de trouble de conscience
- B. En présence d'une contracture abdominale
- C. En présence d'un pneumopéritoine
- D. Lorsqu'elle est stercorale
- E. Lorsqu'elle est secondaire à une étiologie néoplasique

Objectif 6



Les signes cliniques de gravité d'une péritonite aigue sont:

- A. Un état de choc
- B. Une acidose métabolique
- C. Une contracture abdominale
- D. Une polypnée
- E. Un toucher rectal douloureux

Objectif 6



Une péritonite est jugée grave lorsqu'elle est :

- A. Secondaire à une perforation ulcéreuse
- B. Secondaire à une perforation diastatique du ceacum
- C. Secondaire à une appendicite
- D. Secondaire à une perforation tumorale
- E. Secondaire à une cholécystite aigue

Objectifs éducationnels



- 1- Définir les péritonites aiguës (PA)
- 2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA
- 3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA
- 4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA
- 5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA
- 6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA
- 7- Etablir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques**
- 8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques

Objectif 7



La péritonite aigue peut compliquer:

A- une appendicite aigue

B- fréquemment une angiocholite aigue

C- un ulcère gastrique

D- un étranglement herniaire

E- une pyélonéphrite aigue

Objectif 7



Au cours d'une péritonite par perforation d'ulcère duodénal:

A- la fièvre est constante

B- la défense peut être localisée

C- les vomissements sont fréquents

D- le début de la douleur est épigastrique

E- L'installation de la douleur est progressive

Objectif 7



Une péritonite aiguë généralisée par perforation d'ulcère peut donner:

A- Un météorisme abdominal

B- Une contracture abdominale

C- Une disparition de la matité pré-hépatique

D- Une masse de la fosse iliaque droite

E- Un TR normal

Objectif 7



Le pneumopéritoine:

- A. Est inconstant en cas de perforation d'ulcère duodénale
- B. Est présent en cas de péritonite biliaire
- C. Est constant en cas de perforation appendiculaire
- D. Est volumineux en cas de perforation colique
- E. Est visible sur une radiographie ASP couché de face

Objectif 7



Concernant les péritonites appendiculaires :

A- La température est autour de 37,5°

B- Le début de la douleur est au niveau de la fosse iliaque droite

C- Les vomissements sont précoces

D- Sont d'installation rapide chez l'enfant

E- Peuvent se voir à tout âge

Objectif 7



La péritonite appendiculaire:

- A- Peut survenir en absence d'un syndrome appendiculaire
- B- Peut être secondaire à une appendicite non perforée
- C- Peut être secondaire à une rupture d'un plastron abcédé
- D- Peut être précédée par une accalmie de la douleur appendiculaire
- E- Est de mauvais pronostic

Objectif 7



La péritonite biliaire se caractérise par:

A- La survenue chez les femme de plus de 50 ans

B- L'antécédent de douleur à type de pesanteur

C- Un début de la douleur au niveau de l'hypochondre droit

D- Un ictère

E- Une évolution à bas bruit

Objectif 7



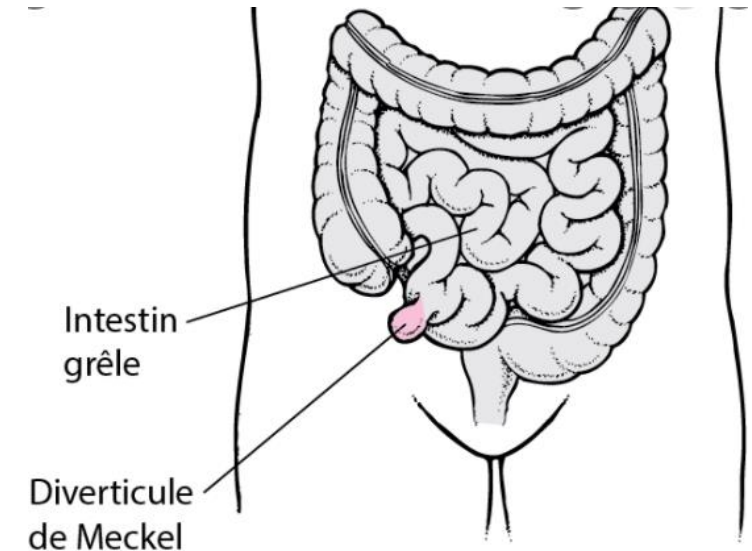
Parmi les causes de péritonites biliaires on trouve:

- A. Une angiocholite aigue
- B. Une cholécystite aigue
- C. Une contusion du foie
- D. Une tumeur du pancréas
- E. Une Cholangite sclérosante primitive

Objectif 7

Les causes de péritonites d'origine jéjunale sont:

- A. Le Diverticule de Meckel
- B. La Fièvre typhoïde
- C. La Rectocolite ulcéro-hémorragique
- D. L'occlusion sur bride
- E. La contusion de l'abdomen



Objectif 7



Les péritonites d'origine colique :

- A. Sont fréquentes chez le sujet jeune
- B. Peuvent être purulente
- C. La perforation tumorale constitue la cause la plus rare
- D. L'origine diverticulaire est la plus fréquente
- E. Peuvent être post traumatique

Objectif 7

Les péritonites au cours d'une colite aigue:

- A. Surviennent essentiellement chez un sujet sous corticoïdes
- B. Peut être secondaire à une colite virale
- C. Sont stercorale
- D. Sont de faible mortalité
- E. Sont dominées par la colite aigue grave sur RCH

Objectif 7



La péritonite stercorale:

- A. Est chimique au début
- B. Est asthénique
- C. Se voit fréquemment chez le sujet âgé
- D. Peut être d'origine diverticulaire
- E. Est de mauvais pronostic

Objectif 7



Les éléments en faveur d'une péritonite d'origine génitale sont:

- A. Les antécédents de salpingite
- B. Une contraception par dispositif intra utérin
- C. Les antécédents de grossesse extra-utérine
- D. Un toucher vaginal douloureux
- E. Une défense généralisée

Objectif 7



Une péritonite d'origine génitale peut être secondaire à:

- A. Une salpingite aiguë
- B. Un pyosalpinx
- C. Un kyste ovarien fonctionnel
- D. Une ovulation hémorragique
- E. Une endométriose pelvienne

Objectif 7

Les péritonites post opératoires sont évoquées devant :

- A. Une éviscération
- B. Une hyponatrémie
- C. Une diarrhée
- D. Un écoulement de liquide séreux par le drainage
- E. Une augmentation du volume d'aspiration gastrique

Objectif 7



Concernant les péritonites post opératoires :

- A. Les signes généraux sont marqués
- B. Les signes physiques sont masqués
- C. Le diagnostic est clinique
- D. Le traitement est chirurgical
- E. L'antibiothérapie est à large spectre visant de multiples germes communautaires

Objectifs éducationnels



- 1- Définir les péritonites aiguës (PA)
- 2- Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA
- 3- Expliquer les conséquences physiopathologiques des PA
- 4- Décrire les aspects anatomopathologiques des PA
- 5- Préciser les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d'une PA
- 6- Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA
- 7- Établir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques
- 8- Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques**

Objectif 8



Le traitement médical d'une péritonite aigue :

- A. Se base sur une antibiothérapie par voie orale
- B. Se base sur une association d'antibiothérapie
- C. Est commencée en post opératoire
- D. inclut une équilibration des trouble hydro-électrolytique
- E. Peut Inclure une administration de catécholamines

Objectif 8



Au cours d'une péritonite aiguë, l'antibiothérapie doit être:

- A. Synergique
- B. Par voie IV
- C. Active contre les cocci gram (+)
- D. Adaptée aux résultats de l'antibiogramme
- E. administrée dès le diagnostic positif

Objectif 8



Le traitement chirurgicale d'une péritonite aiguë généralisée :

- A. Est indiqué après la pratique d'un scanner abdominale
- B. Peut être par voie élektive
- C. Peut être par voie laparoscopique
- D. Est basé sur une toilette péritonéale abondante
- E. Permet la suppression de la cause dans tout les cas

Objectif 8



Le traitement d'une péritonite appendiculaire généralisée chez l'adulte:

- A. Est fait par laparoscopie, qui est la voie d'abord de référence
- B. Peut être fait par la voie de Mac Burney
- C. Comporte une appendicectomie
- D. Comporte une toilette péritonéale
- E. Comporte une antibiothérapie visant les germes aéro-anareobie

Objectif 8

La cœlioscopie

« open cœlioscopie »

éviter la voie laparoscopique en cas d'un syndrome infectieux sévère avec
tendance à l'état de choc septique

Objectif 8



Concernant le traitement chirurgical d'une péritonite aigue généralisée par perforation duodénal:

- A. La toilette péritonéale est faite par voie laparoscopique
- B. La bi vagotomie est pratiquée en routine
- C. La suture de la perforation est systématique
- D. Est encadré par une antibiothérapie
- E. Est indiqué dans tous les cas

Objectif 8



Le traitement chirurgical d'une péritonite par perforation néoplasique du colon gauche peut être fait par :

- A. Une intervention de HARTMANN
- B. Une intervention de Bouilly Volkmann
- C. Une colostomie d'amont
- D. Une colectomie segmentaire avec anastomose colo rectale
- E. Une colectomie totale avec une anastomose iléo rectale

Annexe 1. Arbre décisionnel devant une suspicion d'appendicite : proposition du groupe d'orientation

